

Interpretación de las orientaciones del Fondo Mundial

Preguntas frecuentes

¿Qué contiene esta guía?

1. ¿Qué ha comunicado hasta ahora el Fondo Mundial?	1
2. ¿En qué consistió el «aplazamiento» de la aplicación?	2
3. ¿Qué es «redefinición y revisión»?	4
4. ¿Cómo se llevarán a cabo las Revisiones de las Subvenciones?	9
5. ¿Cómo está desplegando el Fondo Mundial el lenacapavir?	12
6. ¿Cómo afectará esto al Ciclo de Subvenciones 8?	13
7. ¿Cómo pueden participar las comunidades en la toma de decisiones?	14
8. ¿Qué puedo hacer si se cancelan los programas comunitarios?	18
9. ¿Cómo puedo solicitar asistencia?	19
10. Plantillas de correo electrónico	21

1. ¿Qué ha comunicado hasta ahora el Fondo Mundial?

1.1 ¿Qué ha comunicado el Fondo Mundial a los países?

El 25 de abril, la Secretaría orientó a los receptores principales (RPs) sobre la necesidad de «aplazamiento» el gasto de las subvenciones del Fondo Mundial para determinadas actividades. [El mensaje completo puede consultarse aquí.](#)

Además, el 16 de mayo, la Secretaría publicó orientaciones sobre medidas adicionales de adaptación de las subvenciones para el Ciclo de Subvenciones 7 (CS7). Estas orientaciones se centran en la necesidad de reasignar fondos de determinados portafolios de subvenciones, de re-priorizar las actividades para el resto del CS7 y de procesar las revisiones de las subvenciones, según fuera necesario. [El mensaje completo puede consultarse aquí.](#)

El 6 de junio, la Secretaría publicó orientaciones detalladas sobre el enfoque de reasignación de prioridades, que incluyen detalles técnicos sobre las actividades que deben y no deben despriorizarse. [El documento completo puede consultarse aquí.](#)

El 8 de julio, el Fondo Mundial publicó una guía operativa adicional en la que se detallan las políticas y los procedimientos para orientar a los RP, los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y la Secretaría del Fondo Mundial en el ejercicio de revisión y repriorización de mitad de ciclo de la CS7. [Esta guía está disponible aquí.](#)

1.2 ¿Cuál es el motivo de estas comunicaciones?

El Fondo Mundial está financiado por donantes públicos y privados en un ciclo de reposición de tres años. Una vez acordados los compromisos de aportación de recursos, los donantes deben transferir los fondos a la Secretaría del Fondo Mundial para que puedan gastarse. Este proceso se denomina «conversión de promesas».

Al 18 de junio de 2025, la Secretaría ha recibido US\$ 9.10 millones de sus donantes. Alrededor del 42%, es decir, 6.69 millones de dólares, están aún pendientes de recibir. Algunos donantes no han dejado claro que tengan intención de transferir el resto de sus promesas, mientras que otros han retrasado la transferencia de los fondos.

Esta situación está creando un grave riesgo financiero para el Fondo Mundial. Para evitar quedarse sin fondos, el Fondo Mundial está proponiendo tanto pausar ciertas partes de la ejecución de las subvenciones hasta que se transfieran los fondos (lo que aquí se denomina «aplazamiento») como recortar cierto porcentaje de las subvenciones nacionales y volver a priorizar las actividades (lo que aquí se denomina «redefinición y revisiones»).

2. ¿En qué consistió el «aplazamiento» de la aplicación?

2.1 ¿Qué actividades se sugiere pausar?

La «ralentización» del gasto tiene por objeto pausar algunas áreas de inversión que son menos críticas o sensibles al tiempo, entre tanto se **garantiza la continuidad de los programas esenciales y que salvan vidas**. La Secretaría del Fondo Mundial ha

dado instrucciones para que la siguiente lista de actividades **se detenga, reduzca o ponga en pausa inmediatamente**:

1. Mejoras de infraestructura que aún no han progresado sustancialmente, o que aún no han demostrado de forma convincente la probabilidad de que se completen con éxito antes de que finalice el CS7.
2. Adquisición de nuevos vehículos, equipos informáticos, de laboratorio y de otro tipo.
3. Asistencia a conferencias/viajes de estudio.
4. Formación independiente en el lugar de trabajo, tipo taller (por ejemplo, formación de actualización), sobre una única enfermedad para RHS/TSC (cualquier cuadro, incluidos los pares).
5. Costes de reuniones para el desarrollo, la coordinación, la validación y la difusión de políticas, incluidos lugares de reunión, dietas y refrigerios. Las reuniones esenciales que promueven la integración y la sostenibilidad (por ejemplo, la finalización de un plan de sostenibilidad de TCS) pueden recibir apoyo, pero deben ser demostrablemente más reducidas en términos de costes relacionados con los viajes (número de participantes, duración de la reunión, etc.). Los costes relacionados con los viajes para que los PCV participen en foros técnicos e informen sobre la toma de decisiones pueden mantenerse para garantizar procesos inclusivos y equitativos.
6. Nuevas encuestas, estudios, evaluaciones y revisiones, incluidas encuestas de indicadores de malaria (MIS), encuestas demográficas y de salud (DHS), encuestas de prevalencia (por ejemplo, tuberculosis), encuestas de resistencia a los medicamentos contra el VIH, vigilancia biológica conductual integrada (IBBS), revisiones nacionales de la calidad de los datos (DQR), evaluaciones armonizadas de instalaciones sanitarias (HHFA), evaluaciones rápidas de impacto (RIA), encuestas de investigación operativa y estudios para la elaboración de informes de KPI **que aún no han comenzado**.
7. Materiales impresos y costes de publicación, excepto para las herramientas de recopilación de datos y elaboración de informes, si no están digitalizados.
8. Programas/materiales de cambio de comportamiento, campañas en los medios de comunicación (por ejemplo, para la prevención del VIH) y actos de lanzamiento (por ejemplo, campañas contra la malaria).
9. EPI (equipos de protección individual) que no sean esenciales para la protección del personal o de los pacientes.
10. Días conmemorativos, actos genéricos en los medios de comunicación y campañas que incluyan productos relacionados (camisetas, cuadernos, bolígrafos).

11. Actividades de promoción independientes. Excepciones: las que hayan demostrado su eficacia para influir en los responsables políticos o en el mantenimiento de los servicios esenciales o estén vinculadas al uso de datos de monitoreo dirigido por la comunidad (CLM).
12. Supervisión de una sola enfermedad/servicio.
13. Costes operativos.

2.2 ¿Durante cuánto tiempo se detendrá la ejecución de estas actividades?

En las cartas enviadas a los países con sus sobres de financiamiento revisados, el Fondo Mundial indicó que «todas las actividades que se acordó aplazar como parte de las medidas de adaptación introducidas en abril de 2025 permanecerán en pausa a menos que el Fondo Mundial vuelva a aprobar su ejecución». Esto significa que las actividades que quedaron «en pausa» durante el aplazamiento no se reanudarán automáticamente, pero **pueden reiniciarse si se solicitan formalmente** durante el ejercicio de redefinición de prioridades.

3. ¿Qué es «redefinición y revisión»?

3.1 ¿Qué es la redefinición de prioridades y en qué se diferencia de la aplazamiento?

En la reunión de la Junta Directiva del Fondo Mundial de mayo, la Secretaría compartió sus planes para iniciar un **nuevo proceso llamado «redefinición y revisión»**. Esto se suma al aplazamiento de la ejecución, que ocurre aproximadamente al mismo tiempo.

Este proceso de «redefinición y revisión» implicó en primer lugar la comunicación por parte de la Secretaría de la reducción de los importes de financiación el 30 de junio de 2025. Esto significa que la financiación de subvenciones disponible para gastar será menor. Después de esto, los países pasarán por el proceso de revisión de las subvenciones, en el que se tomarán decisiones sobre qué programas recortar, modificar, mantener o pasar a otras fuentes de financiación (por ejemplo, financiación nacional).

3.2 ¿Cambia esto la cuantía de las subvenciones de mi país?

Sí, el **proceso de redefinición reduce el importe de las subvenciones**. Esto contrasta con el aplazamiento, que supuso una pausa en la ejecución de las actividades.

El 30 de junio de 2025 se comunicó por carta a cada MCP la cantidad de fondos que se iba a retirar de cada país. La Secretaría utilizó una fórmula para calcular la cantidad por país, que se basaba principalmente en la cantidad de fondos restantes que no se habían gastado. A continuación, esta cantidad se ajustó utilizando varios «ajustes cualitativos», entre los que se incluyen:

- Ajustarse a la metodología de asignación
- Poner en marcha innovaciones que cambien las reglas del juego, como LEN.
- Mantener las intervenciones críticas del CS7.
- La aceptación nacional de las actividades y los compromisos de cofinanciación.
- Dependencia del país de la financiación del gobierno estadounidense (PEPFAR, PMI)
- Entorno operativo difícil

Las dotaciones de financiación revisadas para cada país están disponibles aquí.

Los detalles sobre los importes revisados **a nivel de subvención están disponibles aquí.** Por término medio, los países han recibido un recorte del 11%, que oscila entre el 0% y el 24%.

Nota: Este proceso no afecta a los fondos C19RM, pero podría afectar a las contribuciones del sector privado, las inversiones catalizadoras (como los fondos de contrapartida) o las transacciones de financiación combinada.

3.3 ¿Cuál es el calendario para la redefinición de las prioridades y la revisión?

El calendario previsto para la redefinición de prioridades y la revisión es el siguiente

- 30 de junio: La Secretaría comunicó a los RP y a los MCP las cartas con los sobres de financiación por país revisados. **Comenzó un periodo de revisión de dos semanas para el MCP.**
- 14 de julio: Al final del periodo de revisión de dos semanas, el MCP tenía de plazo para aprobar los importes de subvención revisados. Se emitirá una carta de notificación final que reflejará los importes acordados.

- Finales de julio: Los Equipos de País decidirán con los RP qué subvenciones, si las hay, tendrán que pasar por el proceso de Revisión de Subvenciones
- A finales de julio: El Fondo Mundial propone que el MCP en pleno se reúna al menos una vez para debatir la redefinición de las prioridades de las intervenciones.
- De mediados de julio a finales de agosto: Si procede, los RP, los MCP y el Fondo Mundial trabajan para revisar los documentos de la subvención. Una vez finalizadas las revisiones de la subvención, los RP enviarán la solicitud de revisión de la subvención al MCP de acuerdo con el proceso existente de revisión de subvenciones.
- Finales de agosto: **El MCP dispondrá de un plazo de dos semanas para revisar**, debatir y aprobar la solicitud final de revisión de la subvención.
- 30 de agosto: El RP presentará los documentos finales de revisión al Fondo Mundial y al MCP
- 30 de septiembre: Fecha límite para que los RP firmen las Cartas de Implementación de todas las Revisiones de Subvenciones.

El plazo para la participación del MCP es muy corto. Para participar en la toma de decisiones, es importante preparar sus prioridades, realizar consultas y ponerse en contacto con sus MCP lo antes posible.

3.4 ¿Qué actividades NO deben despriorizarse durante el proceso de redefinición y revisión?

El 6 de junio, el Fondo Mundial publicó unas orientaciones que definen qué actividades deben mantenerse y cuáles no. Estas orientaciones están **disponibles aquí** y muestran exactamente qué intervenciones deben y no deben ser despriorizadas.

En general, deben observarse los siguientes principios y consideraciones:

Equidad, derechos humanos, género y sistemas comunitarios:

- Deben priorizarse las intervenciones para **reducir las barreras** a la salud (relacionadas con la equidad, los derechos humanos y el género) y abordar la estigmatización, la discriminación y la violencia de género.
- **Deben mantenerse y reforzarse los sistemas comunitarios** (incluida la preservación de los cuadros de pares comunitarios y la prestación de servicios dirigida por la comunidad)

- Los servicios sólo pueden **integrarse en los servicios de atención primaria** si son accesibles y aceptables para las poblaciones más afectadas, y la integración debe incluir actividades que garanticen una atención inclusiva, respetuosa, libre de estigma, sensible al género y adecuada a la edad.
- Deben mantenerse los mecanismos de **monitoreo liderados por la comunidad** (CLM) y los mecanismos de rendición de cuentas.
- Las prioridades comunitarias no deben **reducirse desproporcionadamente** en relación con otras actividades. Todas las decisiones de priorización deben tener en cuenta los impactos y las consecuencias imprevistas en las poblaciones clave y vulnerables.

VIH:

- **Prioridad 1.** Tratamiento y atención del VIH, adquisición de antirretrovirales, suministro de antirretrovirales, apoyo a la continuación del tratamiento, diagnóstico y gestión de la tuberculosis y la enfermedad avanzada por VIH (AHD).
- **Prioridad 2.** Vinculación de las personas que viven con el VIH con el tratamiento, la atención y el apoyo, prevención del VIH, pruebas del VIH para las personas con mayor riesgo de contraer el VIH (especialmente mediante pruebas índice y servicios asociados), pruebas del VIH (en clínicas de TB, clínicas de ITS, clínicas de atención prenatal, como parte de los programas PC e iniciadas por el proveedor), y profilaxis antirretrovírica y diagnóstico precoz del lactante (DPE) para los lactantes expuestos al VIH.
- **Prioridad 3.** Preservativos y lubricantes, PrEP para los usuarios actuales e iniciación para los de mayor riesgo, reducción de daños (tratamiento con agonistas opiáceos e inyecciones seguras), PEP, integración de la prevención del VIH en los servicios existentes de SSR/ITS/planificación familiar (PF).

Tuberculosis:

- Integración (dentro de la tuberculosis y con otras enfermedades y sectores) y optimización del uso de los recursos y herramientas, enfoques y algoritmos existentes y aceleración de la transición a nuevas herramientas cuando estén disponibles a lo largo de la cascada asistencial.

Malaria:

- El objetivo principal es minimizar la mortalidad por malaria. Los componentes esenciales son los que garantizan la disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad de servicios de calidad y la supervisión de su aplicación.

- **Prioridad 1.** Garantizar el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos de calidad para los enfermos es un pilar central.
- **Prioridad 2.** Intervenciones de prevención, como el control de vectores y la quimioprevención estacional de la malaria.
- Lo ideal sería que un programa tuviera como objetivo alcanzar y mantener la cobertura universal del control de vectores, superponiendo la quimioprevención estacional en zonas con una transmisión estacional muy alta.
- La vigilancia es transversal a todas las intervenciones y debe racionalizarse con actividades priorizadas para garantizar datos suficientes para la toma de decisiones.
- A la hora de priorizar poblaciones o áreas geográficas, debe prestarse especial atención a mantener una perspectiva de equidad, especialmente en contextos de entornos operativos complicados, en los que determinadas poblaciones pueden tener un acceso limitado a los servicios contra la malaria.

SSRS:

- Los países deben financiar las intervenciones en enfermedades de una manera más integrada y sostenible, incorporando la equidad, los derechos humanos y la igualdad de género en cada intervención, al tiempo que dan prioridad al fortalecimiento de los sistemas para lograr el máximo impacto y resiliencia.
- La priorización de las actividades específicas de la enfermedad debe considerarse junto con las áreas de priorización de los SSRS, incluidos los recursos humanos para la salud (en particular los TCS), los sistemas de cadena de suministro, la prestación y el seguimiento de servicios basados y dirigidos por la comunidad, los sistemas de datos (HIS, LMIS, laboratorio, etc.), los sistemas integrados de laboratorio y otras funciones sanitarias que apoyan la calidad y el acceso equitativo a las actividades específicas de la enfermedad.

3.5 ¿Cuál es el papel de la financiación nacional?

Las decisiones sobre la dotación de fondos se basarán en los recursos nacionales disponibles para la salud. Esto puede implicar la **transición de algunas actividades** del apoyo del Fondo Mundial al sistema sanitario público, lo que se denomina «integración».

Desde la perspectiva de la comunidad, hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta:

1. **¿Existen determinadas actividades que el gobierno no puede realizar o no puede realizar de forma eficaz?** Por ejemplo, en un contexto en el que se criminaliza a las poblaciones clave, ofrecer programas centrados en la PC en una clínica de salud pública puede dar lugar a que los pacientes sean rechazados, no reciban los servicios que necesitan o sufran estigmatización, discriminación y una atención insegura.
2. **¿Qué actividades de las subvenciones deberían transferirse a los gobiernos?** ¿Podrían incluirse actividades no centradas en las comunidades, como la adquisición de medicamentos, los sistemas de laboratorio, los recursos humanos para la salud y la distribución de productos básicos?
3. **¿Invierte lo suficiente el gobierno?** En algunos casos, puede abogar por que el gobierno invierta más recursos nacionales para evitar grandes recortes en el programa del Fondo Mundial. ¿Están cumpliendo los gobiernos sus requisitos de cofinanciación?
4. **¿Con qué rapidez puede producirse la integración?** Es importante considerar la rapidez con la que el gobierno puede hacerse cargo de los programas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevaría formar a los trabajadores sanitarios para que se hicieran cargo de los programas centrados en la comunidad? Es posible que desee abogar para que no se eliminen programas del Fondo Mundial si el proceso de traspaso puede llevar muchos meses o incluso años.
5. **¿Existen barreras legales o políticas para la integración?** En el caso de los programas que deben ser ejecutados por organizaciones dirigidas por la comunidad, ¿puede el gobierno contratar a organizaciones comunitarias para que sigan ejecutando estos programas? ¿Qué pasos legales son necesarios antes de que se pueda llevar a cabo esta contratación?

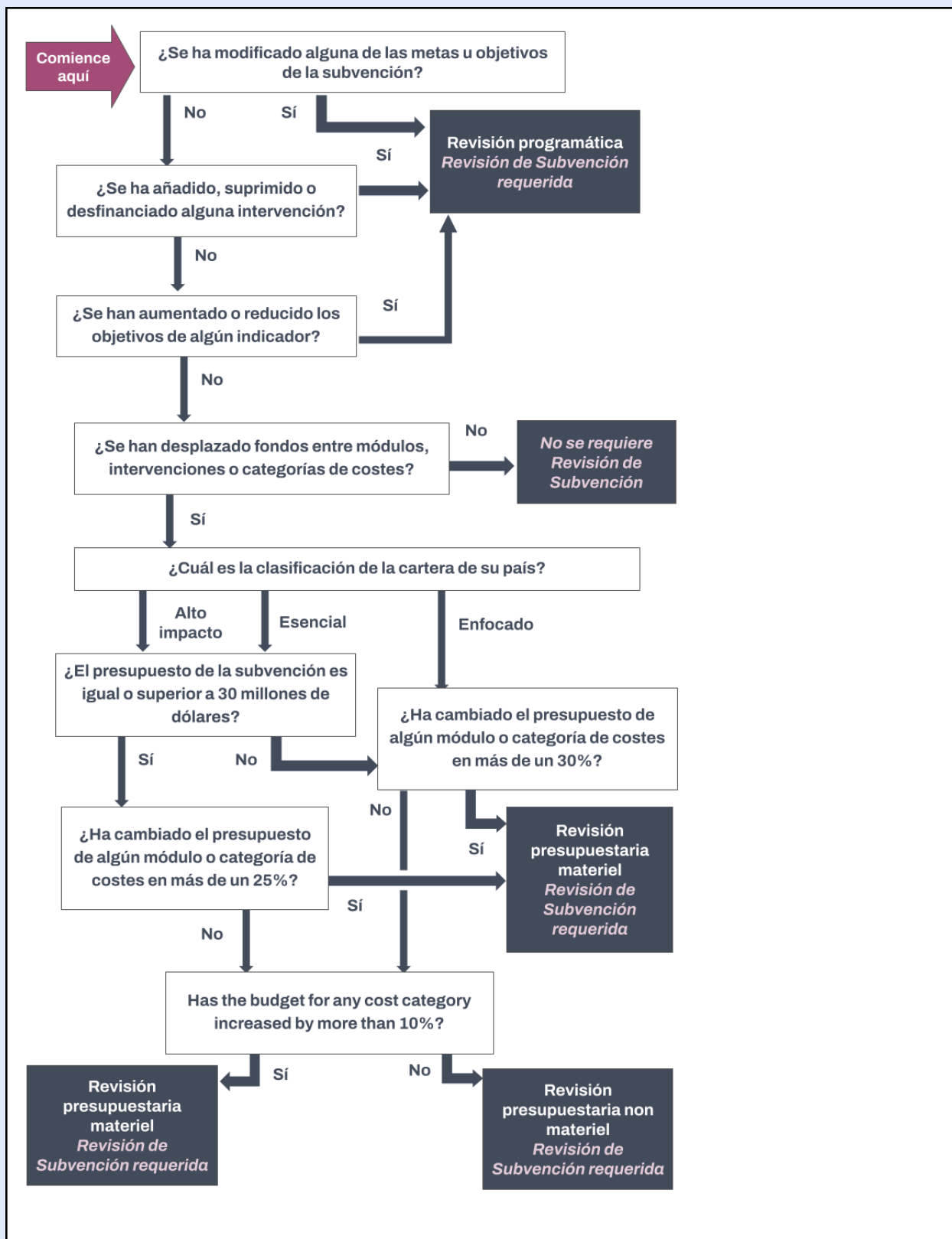
4. ¿Cómo se llevarán a cabo las Revisiones de las Subvenciones?

4.1 ¿Qué sucede después de que el MCP apruebe las dotaciones de financiación revisadas?

Después del 14 de julio, el Equipo de País en Ginebra y los RP decidirán si una o más subvenciones deberán someterse a una revisión programática o presupuestaria. Si los cambios en las subvenciones son tan mínimos que no desencadenan una revisión de

la subvención, no habrá más pasos en la revisión de las prioridades del CS7 y el **ejercicio habrá concluido**.

A continuación se indican los factores desencadenantes de los tres tipos de revisiones de subvenciones (programática, presupuesto material y presupuesto no material). Si no está seguro de la categorización de la cartera de su país, [puede encontrarla aquí](#).



Documento actualizado por última vez el 14 de julio de 2025 || Para más información, [contáctenos](#) o comparta sus [preguntas aquí](#).

4.2 ¿Quién aprueba las Revisiones de las Subvenciones?

En el caso de una **revisión programática**, dos miembros del MCP deben dar su aval: el Presidente del MCP y el representante de la sociedad civil. Si el representante de la sociedad civil es el Presidente del MCP, entonces tanto el Presidente del MCP como el representante del gobierno deben dar su aval. Este período de aprobación tendrá lugar a finales de agosto, cuando los dos miembros del MCP dispondrán de un plazo de dos semanas para examinar la propuesta de revisión de la subvención y dar su aprobación.

El Fondo Mundial recomienda encarecidamente a los RP que presenten revisiones programáticas **al MCP en pleno; sin embargo, esto no es obligatorio**. Además, si el Presidente del MCP y el representante de la sociedad civil no dan su aprobación en el periodo de revisión de dos semanas, la Secretaría del Fondo Mundial seguirá adelante con el proceso de aprobación de la revisión de la subvención.

Para una **revisión presupuestaria**, no se requiere el aval del MCP. Sin embargo, el RP debe informar al MCP cuando se esté procesando una revisión material del presupuesto.

Esto significa que, durante el proceso de revisión de la subvención, es imperativo que las comunidades se pongan en contacto de forma proactiva con sus RP, ya que **no es necesario que el MCP en pleno respalde o apruebe formalmente** ninguna revisión de la subvención.

4.3 ¿Revisará el PRT las Revisiones de Subvenciones?

No es obligatorio que el Panel de Revisión Técnica (PRT) revise las Revisiones de Subvenciones. Sin embargo, en algunos casos los cambios propuestos como parte de una revisión programática son tan significativos que requieren una «**revisión intensificada**». En este caso, el Equipo de País puede solicitar una revisión del PRT. Algunos ejemplos de situaciones que requieren una revisión intensificada son

- La discontinuación de un RP o subreceptor que sea una Organización de la Sociedad Civil (OSC)
- Casos en los que los costos programáticos no se ajusten para que coincidan con las reducciones de la asignación
- Cuando se agregaron nuevas actividades a la subvención del Fondo Mundial para llenar los vacíos dejados por el retiro de otros donantes, o

- Escenarios en los que los cambios en la subvención afectarán el acceso equitativo a los servicios que salvan vidas.

En los casos en los que **exista un desacuerdo** entre el Equipo de País, el RP y/o el MCP sobre el enfoque de repriorización, también se puede solicitar una revisión del PRT. Solicitar una revisión del PRT puede ser una **estrategia importante de escalada** si hay desacuerdos importantes entre los miembros del MCP comunitario y los RP o el Equipo de País.

5. ¿Cómo está desplegando el Fondo Mundial el lenacapavir?

5.1 ¿Qué es el lenacapavir?

La profilaxis preexposición (PrEP) con lenacapavir es un inyectable de acción prolongada para la prevención del VIH. A diferencia de las formas orales de PrEP, lenacapavir (LEN) se administra como una inyección dos veces al año que proporciona el mismo nivel de protección que otras formas de PrEP. Los datos de los ensayos clínicos revelan que $\geq 99,9\%$ de los participantes permanecieron seronegativos mientras tomaban la LEN PrEP.

El 18 de junio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (**FDA**) **aprobó** LEN (nombre comercial Yeztugo®) como la primera y única opción dos veces al año para las personas que desean la PrEP. Tras esta aprobación, el 9 de julio, el Fondo Mundial **anunció un acuerdo de acceso** con Gilead, el fabricante del medicamento, que le permite adquirir LEN para los países apoyados por el Fondo Mundial.

Esto **sigue a un anuncio** realizado el 17 de diciembre de 2024, en el que el Fondo Mundial y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) anunciaron su intención de aumentar el acceso a la LEN. Los dos donantes indicaron el objetivo de proporcionar LEN a al menos 2 millones de personas en tres años, en países apoyados por el Fondo Mundial y el PEPFAR, con el apoyo de la Children's Investment Fund Foundation (CIFF) y la Fundación Gates.

5.2 ¿Cuándo y dónde se implantará lenacapavir?

Documento actualizado por última vez el 14 de julio de 2025 || Para más información, [contáctenos](#) o comparta sus [preguntas aquí](#).

En virtud del acuerdo con Gilead, los siguientes países recibirán acceso temprano a la LEN PrEP: **Eswatini, Kenya, Lesotho, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabwe**. La decisión sobre qué países recibirán acceso temprano fue tomada por el Fondo Mundial, basándose en la epidemiología del VIH, las estrategias nacionales de prevención y los recursos disponibles.

El Fondo Mundial ha afirmado que el primer envío y entrega del producto llegará al menos a un país africano **a finales de 2025**.

5.3 ¿De dónde procederá la financiación del lenacapavir?

Para cada uno de los nueve países seleccionados para el acceso temprano, el Fondo Mundial incluyó orientaciones específicas en sus cartas de repriorización. A cada país se le dio la opción de aceptar ser un país de adopción temprana y se le notificó la cantidad de financiamiento de la subvención del CS7 que debería utilizarse para financiar la LEN PrEP.

Los importes de financiación anunciados en las cartas **no son recursos nuevos**, sino que deben proceder de subvenciones existentes del Séptimo Programa Mundial. Esto significa que, para recibir la LEN PrEP, los países deben quitar prioridad a otras actividades de subvención con el fin de disponer de fondos.

6. ¿Cómo afectará esto al Ciclo de Subvenciones 8?

6.1 ¿Qué sabemos del Ciclo de Subvenciones 8?

Normalmente, la Conferencia de Reposición tiene lugar en septiembre u octubre. Después, la Junta Directiva del Fondo Mundial aprueba la Fuente de Fondos en la reunión de noviembre. A continuación, se aplica la Metodología de Asignación a los fondos disponibles, que calcula la cantidad de financiamiento disponible para cada país, y las cartas de Asignación se envían a cada país en diciembre.

Debido a la incertidumbre en torno a la 8ª Reposición, los **plazos se están retrasando**, para evitar tomar decisiones sobre los fondos disponibles antes de que se hayan realizado todas las promesas.

Por este motivo, la reunión de la Junta Directiva de noviembre se ha trasladado a febrero de 2026, y las cartas de asignación se comunicarán a los países a finales de febrero o principios de marzo de 2026.

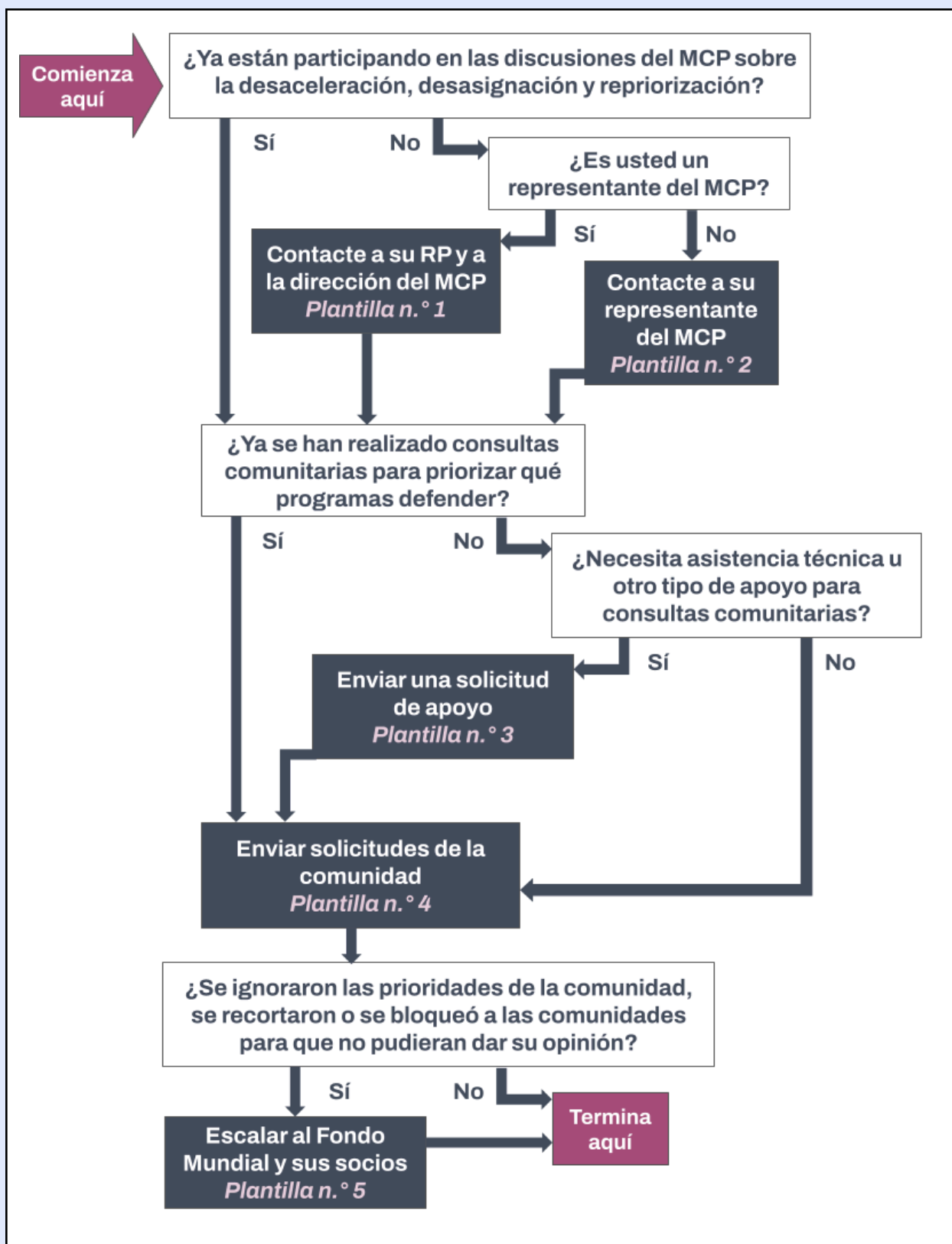
7. ¿Cómo pueden participar las comunidades en la toma de decisiones?

7.1 ¿Quién decide qué actividades se volverán a repriorizar?

El 30 de junio, los Equipos de País (EC) del Fondo Mundial se pusieron en contacto con los Receptores Principales (RP) y el MCP para compartir la dotación de financiamiento revisada para el resto del CS7. A continuación, el MCP dispuso de dos semanas para revisar y dar su opinión, y la aprobación final tuvo lugar el 14 de julio.

La siguiente fase del compromiso son las Revisiones de Subvenciones, para los países en los que se desencadena una Revisión de Subvenciones programática o presupuestaria. Durante esta fase, se tomarán decisiones detalladas para revisar los presupuestos previstos y las actividades programáticas. Sin embargo, aunque el Fondo Mundial solicite la «aprobación», no es necesario que todos los miembros del MCP firmen formalmente. Por ello, existe un alto riesgo de que las decisiones se tomen rápidamente y sin contar con la opinión de las comunidades. Las comunidades deben ponerse **en contacto de forma proactiva y regular** con su MCP y con la Secretaría para hacerles llegar sus comentarios y aportaciones.

7.2 ¿A quién debo dirigirme para participar?



Documento actualizado por última vez el 14 de julio de 2025 || Para más información, [contáctenos](#) o comparta sus [preguntas aquí](#).

7.3 ¿Qué pruebas deben aportar las comunidades al MCP?

Las decisiones sobre qué programas pausar o despriorizar serán todo un reto, y habrá muchas prioridades que compitan por la financiación. Para defender eficazmente las prioridades comunitarias, **deberá aportar evidencias** de la importancia y eficacia de la programación comunitaria.

1. **Revisar la subvención actual.** El primer paso es saber qué actividades se financian actualmente en las subvenciones activas. Usted puede tener acceso a esta información a través de su MCP, o puede encontrar datos detallados sobre los presupuestos de las subvenciones en el [Explorador de Datos](#) del Fondo Mundial o en este [Tablero del MCP](#).
2. **Categorice las actividades utilizando el lenguaje del Fondo Mundial.** El Fondo Mundial ha destacado específicamente los tipos de actividades que no deben recortarse. Si usted puede defender por qué los programas centrados en la comunidad se ajustan a esos criterios, tendrá más probabilidades de éxito. Utilice pruebas de su organización, redes y comunidad, así como de los programas de monitoreo liderados por la comunidad (CLM).

Lenguaje del Fondo Mundial	Ejemplos de cómo puede describir los programas comunitarios
Los programas deben «salvar vidas»	Explique por qué «dirigidos por la comunidad» salvan vidas. Los programas ejecutados por y para las comunidades salvan vidas. Las organizaciones comunitarias son responsables de prestar servicios vitales a las personas más afectadas por el VIH, la TB y la malaria (VTM). Sin ellas, los medicamentos y los productos básicos permanecerán inutilizados en almacenes y clínicas. Si dejamos de financiar programas comunitarios, perderemos a estos ejecutores de confianza, y nuestras poblaciones más vulnerables perderán la atención que necesitan para seguir con vida.
Los programas deberían estar «más integrados con el gobierno»	Describe por qué algunos programas no pueden integrarse inmediatamente. Los centros sanitarios públicos son una parte fundamental de la prestación de servicios. Sin embargo, la evidencia de nuestra comunidad es que

	los clientes de las poblaciones clave han sido rechazados y se enfrentan a abusos por parte del personal de las clínicas. Debemos seguir financiando los servicios comunitarios para quienes, de lo contrario, dejarán de recibir una atención que puede salvarles la vida.
Los programas deben «dar prioridad a las personas afectadas de forma desproporcionada por el VTM».	Destacar cómo los programas comunitarios atienden a las poblaciones más afectadas. Las personas desproporcionadamente afectadas por el VTM son poblaciones clave y vulnerables. Llegar a estas poblaciones con servicios que salvan vidas es esencial. Sin embargo, estas mismas poblaciones a menudo se enfrentan a importantes obstáculos para recibir servicios en entornos tradicionales, ubicados en puestos de salud y prestados por médicos. La prestación de servicios en entornos seguros, basados en la comunidad y a través de socios locales y de confianza ha demostrado una y otra vez ser la estrategia más eficaz para llegar a estas poblaciones.
Los países deben mantener el «paquete mínimo de servicios necesarios para prestar un servicio de calidad en este entorno».	Describir cómo la prestación de asistencia sanitaria sólo puede realizarse con socios comunitarios. La compra de medicamentos y productos básicos sólo es útil si se entregan a las personas que más los necesitan. Las personas que los necesitan suelen estar marginadas y estigmatizadas y se enfrentan a grandes dificultades para acceder a la atención en los centros públicos. El Fondo Mundial apoya los programas comunitarios tienen impacto porque sin ellos no hay forma de llegar a estas poblaciones con servicios de calidad que salvan vidas.
Los programas deben demostrar la «rentabilidad»	Explicar cómo las prioridades de la comunidad cumplen las cinco categorías de la optimización de recursos. Según el Fondo Mundial, hay cinco facetas de la rentabilidad: eficacia, eficiencia, economía, equidad y sostenibilidad. Al defender estas prioridades, explique el impacto de estos programas, para demostrar su eficacia. Explique cómo sin la distribución y el compromiso de la comunidad, la eficiencia de los programas disminuirá, ya que no se llegará a las personas que necesitan los servicios.

	Puede explicar cómo los programas comunitarios son económicos, ya que constituyen una parte muy pequeña de las subvenciones, pero tienen un gran impacto en la repercusión de los programas. Sin programas comunitarios, la prestación de servicios no puede ser equitativa y llegar a todas las poblaciones. Por último, el liderazgo comunitario es un pilar fundamental de la apropiación del país y la sostenibilidad a largo plazo: al fomentar la apropiación comunitaria, los programas sanitarios pueden ser duraderos y tener impacto a largo plazo.
--	--

3. **Celebre consultas, siempre que sea posible.** Si puede, celebre consultas comunitarias para elaborar juntos una «petición» compartida. Cuantas más personas y organizaciones aboguen por lo mismo, más fuerte será su voz.
4. **Elabore un documento con sus peticiones y pruebas.** Puedes utilizar la **plantilla nº 4**. Compártalo con todas las partes interesadas de su país, incluidos el MCP, el RP y el PE en Ginebra.

8. ¿Qué puedo hacer si se cancelan los programas comunitarios?

8.1 ¿Qué debo hacer si el RP de mi país interrumpe los programas esenciales de tratamiento, prevención o comunitarios?

Si se enfrenta a algún problema, **lo más importante es actuar con rapidez**, ya que las decisiones se tomarán rápidamente.

1. **Documéntelo todo:** lo primero es documentar lo que está ocurriendo, con el mayor detalle posible. Esto será vital si decide escalar o informar de un problema.
2. **Escale rápidamente:** El plazo de toma de decisiones es muy corto, por lo que es fundamental escalar lo antes posible. Como hay tan poco tiempo, debe compartir sus preocupaciones y problemas con todos los responsables pertinentes a la vez, en lugar de enviar un correo electrónico cada vez. Así se asegurará de que alguien presta atención a su petición. Puede utilizar la **Plantilla nº 5** para escalar.

3. **Comunique el problema a la plataforma comunitaria de escalada.** Esta plataforma está gestionada por la sociedad civil y le permitirá conectar con socios que le ayudarán a ponerse en contacto con las personas adecuadas en el Fondo Mundial, le pondrán en contacto con otras personas que tengan el mismo problema y/o abogarán en su nombre.

9. ¿Cómo puedo solicitar asistencia?

9.1 Me gustaría recibir ayuda para relacionarme con el RP y la Secretaría. ¿Con quién puedo ponerme en contacto?

Existen retos que pueden presentarse al colaborar con el MCP:

1. El MCP le excluye de la toma de decisiones.
2. El MCP le excluye de participar en la toma de decisiones.
3. Se ignoran las peticiones de la comunidad.
4. Se recortan los programas centrados en la comunidad.
5. Los programas centrados en la comunidad se integran en programas gubernamentales, donde existe un alto riesgo de que no se implementen de manera efectiva.

En todos estos casos, hay que **actuar con rapidez y amplitud**. Si espera a que sus preocupaciones se escalen a través de las vías normales, existe el riesgo de que las decisiones se tomen y finalicen.

Puede optar por escalar los problemas usted mismo o solicitar ayuda. Si desea enviar usted mismo los correos electrónicos, puede utilizar la **plantilla nº 3**. Si prefiere trabajar con socios de la sociedad civil para escalar, puede compartir sus retos utilizando **este formulario**.

9.2 ¿Existe alguna ayuda económica para las consultas comunitarias?

Las orientaciones del Fondo Mundial indican que «se anima a los MCP a considerar si pueden asignar financiamiento del MCP para apoyar una participación y consulta más amplias, especialmente para la sociedad civil y las comunidades». Además, en un pequeño número de países puede haber apoyo adicional de la Iniciativa Estratégica de Participación Comunitaria (IE PCI).

Para solicitar apoyo, las comunidades pueden utilizar la ***Plantilla #3*** para solicitar apoyo al MCP y a la Secretaría. Dado que los recursos serán muy limitados, las solicitudes también deberán dirigirse directamente a otros asociados, como los Centros Regionales de Aprendizaje del Fondo Mundial, las Redes de Poblaciones Clave, ONUSIDA, l'Initiative y otros financiadores.

También puede solicitar apoyo utilizando [este formulario](#), que permitirá a los socios de la sociedad civil ponerle en contacto con posibles recursos.

10. Plantillas de correo electrónico

Plantilla n° 1: Para que los miembros del MCP se pongan en contacto con el MCP y RP.

Para: [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP], [Punto(s) focal(es) de RP]
CC: [Derechos Comunitarios y Género], [Otros representantes del MCP, según sea necesario], [Otros socios comunitarios y de la sociedad civil, según sea necesario]

Asunto: Solicitud de participación en la ralentización, el cambio de prioridades y la revisión

Estimados [Presidente del MCP], [Vicepresidente] y [punto focal del RP],

Les escribo en relación con el proceso de «redefinición y repriorización» de las subvenciones del Fondo Mundial. Como miembro del MCP en representación de [sector], me preocupa que el breve plazo previsto por la Secretaría deje poco margen para el debate en el MCP y para una participación y aportaciones significativas de la comunidad.

Las decisiones sobre qué programas recortar, alterar o integrar tendrán un profundo impacto en las comunidades. Es esencial que las voces, perspectivas y experiencia de las comunidades se centren en este proceso.

Solicito lo siguiente:

1. Una **reunión urgente** del MCP para debatir el proceso de reasignación y el calendario, y para desarrollar un plan de consulta comunitaria sólida. Esta reunión debería celebrarse lo antes posible, mucho antes de la comunicación formal de la dotación de fondos revisada a mediados de junio.
2. Compromiso por parte del RP de implicar activamente a los representantes de la comunidad, incluidos los de las poblaciones clave y vulnerables, en los debates sobre la reasignación de prioridades. Esta **participación debe comenzar ahora** y no puede esperar hasta que comience el periodo de revisión de dos semanas del MCP.
3. **Apoyo financiero** para que las comunidades inicien las consultas en torno a este proceso de toma de decisiones, con cargo al presupuesto del MCP y/o recursos adicionales del CCM Hub o del CRG.

Esperamos poder trabajar juntos para garantizar un proceso de reasignación y cambio de prioridades que preserve los servicios vitales y minimice los daños.

Gracias por su atención a este asunto.

Atentamente,

[Su nombre]

[Otros cofirmantes del MCP y/o de la sociedad civil, según sea necesario]

Plantilla nº 2: Para que los no miembros del MCP se pongan en contacto con su representante en el MCP

Para: [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP], [Punto Focal Administrativo del MCP]

CC: [Gerente de Portafolio del Fondo], [Derechos Comunitarios y Género], [Otros socios comunitarios y de la sociedad civil, según sea necesario]

Asunto: Solicitud de participación en la ralentización, redefinición y revisión

Estimado(a) [Nombre(s) de contacto(s) en el MCP],

Les escribo con preocupación en relación con el proceso de «redefinición y repriorización» de las subvenciones del Fondo Mundial. Como [título y organización] y miembro de [sector], espero tener la oportunidad de colaborar con el MCP para garantizar que las perspectivas de la comunidad se incluyan de forma significativa en este proceso crítico de toma de decisiones.

Como miembro de [organización/comunidad], le solicito que

1. Abogue por **una reunión urgente** del MCP para discutir el proceso y cronograma de reasignación y para desarrollar un plan para una consulta comunitaria sólida. Esta reunión debería celebrarse lo antes posible, mucho antes de la fecha límite de mediados de junio.
2. Poner en marcha un **proceso rápido** de consulta para garantizar que los representantes de la comunidad participen activamente en los debates sobre la reasignación de prioridades.

3. **Apoyo financiero** para que las comunidades inicien las consultas en torno a este proceso de toma de decisiones, con cargo al presupuesto del MCP y/o recursos adicionales del Centro del MCP o del CRG.

Esperamos trabajar juntos para garantizar un proceso de redefinición y repriorización que preserve los servicios vitales y minimice los daños.

Gracias por su atención a este asunto y por representar las voces de la comunidad en el MCP.

Atentamente,

[Su nombre]

[Otros cofirmantes de la sociedad civil, en caso necesario]

Plantilla nº 3: Presentar una solicitud de ayuda

Para: [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP], [Punto Focal Administrativo del MCP], [Derechos Comunitarios y Género], [CCM Hub]

CC: [Otros representantes del MCP, según sea necesario], [Otros socios de la sociedad civil y la comunidad, según sea necesario]

Asunto: Solicitud urgente de apoyo para la participación comunitaria en el proceso de cambio de prioridades

Estimado [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP] y colegas del CRG y del CCM Hub,

Me dirijo a ustedes como miembro de [MCP y/o comunidad] en [País]. Estoy profundamente preocupado por el inminente proceso de «redefinición y repriorización» y la falta de participación significativa de la comunidad en esta toma de decisiones crítica.

El periodo de revisión de dos semanas para que el MCP aporte sus comentarios sobre la reasignación de prioridades es extremadamente corto. Esto deja poco espacio para el tipo de consulta comunitaria sólida que es esencial para garantizar que se reflejen las necesidades y prioridades de las poblaciones afectadas.

Solicito el apoyo de la Secretaría para facilitar las consultas comunitarias sobre el proceso de cambio de prioridades de las subvenciones. En concreto, me gustaría recibir [apoyo financiero y/o asistencia técnica] para

1. **Organizar una consulta virtual y/o presencial** con poblaciones clave y vulnerables, organizaciones comunitarias y otras partes interesadas pertinentes. Estas consultas deberían realizarse lo antes posible, mucho antes de la fecha límite de revisión del MCP de mediados de junio.
2. Desarrollar un **proceso estructurado para recoger las aportaciones**, comentarios y recomendaciones de la comunidad sobre los cambios propuestos en el financiamiento y la redefinición de las prioridades de los programas.
3. Sintetizar los resultados de las consultas comunitarias en un **informe exhaustivo** que pueda presentarse al MCP y a la Secretaría del Fondo Mundial.
4. Proporcionar **asistencia técnica y orientación** para garantizar que el proceso de consulta a la comunidad sea inclusivo, significativo y dé voz a los más afectados por los cambios propuestos.

Me complacería tener la oportunidad de debatir más a fondo esta solicitud. Si tienen alguna pregunta o necesitan más información, no duden en comunicármelo.

Gracias de antemano por su consideración y apoyo.

Atentamente,

[Su nombre]

[Otros co-firmantes del MCP y/o de la sociedad civil, según sea necesario].

Plantilla nº 4: Presentar solicitudes comunitarias

Para: [Gestor del Portafolio del Fondo], [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP], [Punto(s) focal(es) del RP].

CC: [Derechos Comunidad y Género], [Jefe, División de Gestión de Subvenciones], [Otros representantes del MCP, según sea necesario], [Otros socios de la sociedad civil y la comunidad, según sea necesario].

Asunto: Presentación de las prioridades comunitarias para su redefinición en [país]

Documento actualizado por última vez el 14 de julio de 2025 || Para más información, [contáctenos](#) o comparta sus [preguntas aquí](#).

Estimado [Gerente de Portafolio del Fondo], [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP], [Punto(s) focal(es) del RP],

En nombre de los actores interesados comunitarios a los que representamos, les escribimos para ofrecerles nuestras recomendaciones y justificaciones sobre los programas que deberían priorizarse y mantenerse durante el próximo proceso de cambio de prioridades de las subvenciones del Fondo Mundial.

Comprendemos las graves limitaciones financieras a las que se enfrenta el Fondo Mundial y la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre la asignación de subvenciones. Sin embargo, creemos firmemente que los programas dirigidos por la comunidad y centrados en la comunidad deben protegerse y priorizarse, ya que son esenciales para lograr la misión del Fondo Mundial, prestar servicios que salvan vidas y garantizar la participación significativa de las poblaciones afectadas.

Basándonos en nuestras consultas, así como en nuestra revisión del actual portafolio de subvenciones, **recomendamos que se mantengan** las siguientes áreas programáticas y que no sean objeto de recortes o reducciones:

1. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación].
2. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación].
3. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación].
4. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación].

Solicitamos al Fondo Mundial que preserve estas prioridades comunitarias urgentes. Estaremos encantados de proporcionar información, datos y justificaciones adicionales que respalden la importancia de estas áreas del programa.

Atentamente,

[Su nombre]

[Otros co-firmantes del MCP y/o de la sociedad civil, según sea necesario]

Plantilla nº 5: Escalar al Fondo Mundial y a los socios

Para: [Jefe de la División de Gestión de Subvenciones], [Gerente de Cartera de Fondos], [Presidente del MCP], [Vicepresidente del MCP], [Punto focal del RP]
CC: [Derechos Comunidad y Género], [Otros representantes del CCM, según sea necesario], [Otros socios de la sociedad civil y comunitarios, según sea necesario]

Asunto: Desafíos urgentes y sensibles al tiempo con el proceso de redefinición en [país]

Estimados [Jefe de la División de Gestión de Subvenciones] y [Gerente de Cartera de Fondos]:

Les escribo con **serias preocupaciones sobre el proceso de toma de decisiones** en torno a la "desasignación y redefinición". A pesar de nuestros mejores esfuerzos por involucrar al [MCP o RP o EP] en consultas significativas con las comunidades afectadas, ahora nos enfrentamos al muy real riesgo de que se recorten programas comunitarios críticos y que salvan vidas.

Específicamente, estamos profundamente alarmados de que los siguientes **programas que salvan vidas estén siendo considerados para reducción o eliminación:**

1. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación de por qué el programa es esencial y las consecuencias de cortarlo]
2. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación de por qué el programa es esencial y las consecuencias de cortarlo]
3. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación de por qué el programa es esencial y las consecuencias de cortarlo]
4. [Nombre del programa]. Justificación: [Explicación de por qué el programa es esencial y las consecuencias de cortarlo]

Estos programas no solo son esenciales para lograr la misión del Fondo Global, sino que también son un salvavidas crítico para las comunidades más marginadas y vulnerables de nuestro país. Cortar o reducir la financiación para estas iniciativas tendría consecuencias devastadoras y socavaría años de progreso en la lucha contra el VIH, la TB y la malaria.

Hemos planteado repetidamente estas preocupaciones al [RP, MCP o EP], pero [explicar - ¿fueron ignoradas? ¿Qué sucedió?]. El corto plazo y el proceso de toma de decisiones opaco están generando serias preocupaciones.

Solicitamos urgentemente su intervención inmediata para:

1. **Suspender el actual proceso de repriorización de subvenciones** hasta que haya habido tiempo suficiente para consultas comunitarias genuinas e inclusivas.
2. Asegurar que los programas comunitarios que salvan vidas, como se describe arriba, estén **explícitamente protegidos y mantenidos** como parte de las carteras de subvenciones revisadas.
3. Proporcionar **participación y apoyo directo** al MCP y al RP para facilitar un compromiso significativo de la comunidad en la toma de decisiones.
4. **Monitorear la situación de cerca** y responsabilizar al [MCP y/o RP] por cumplir con los compromisos del Fondo Mundial con el compromiso comunitario y los derechos humanos.

Agradecemos de antemano su atención urgente a este asunto y su apoyo a las comunidades que servimos.

Atentamente,

[Su nombre]

[Otros co-firmantes del MCP y/o de la sociedad civil, según sea necesario]